

Saúde na Última Semana — Revista Eletrônica VIA

Edição de 4 de outubro de 2026

Semana de 28 de setembro a 4 de outubro de 2026

Curadoria médico-científica · saúde pública, cuidado, ciência e tecnologia

A receita ganhou uma via digital. O cuidado continua dependendo do circuito inteiro: prescrever, conferir, dispensar, registrar e acompanhar.

Em 90 segundos

- Em 30/09, o Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR) abriu a emissão eletrônica integrada de notificações A, B e B2, além das destinadas a retinoides sistêmicos e talidomida. A via eletrônica é uma possibilidade; o papel continua válido.
- O prazo até 29/10 vale apenas para a coexistência de receitas brancas eletrônicas integradas e não integradas ao SNCR. Ele não deve ser transplantado para as notificações A e B.
- A Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) abriu a estratégia formativa do Combo APS: cinco cursos iniciais de 10 horas e materiais para incorporar equipamentos ao trabalho das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Equipamento sem fluxo, treinamento e retaguarda não produz resolutividade por decreto.
- Em 30/09 entrou em vigor a Portaria GM/MS nº 11.685/2026, que atualiza procedimentos hemoterápicos. Serviços de hemoterapia e vigilâncias sanitárias estão em transição enquanto a RDC nº 34/2014 permanece vigente e passa por revisão.
- Ministério da Saúde e Fiocruz assinaram memorando para um segundo laboratório modular de células CAR-T, no Ceará. É infraestrutura de desenvolvimento e produção em implantação — não oferta assistencial já disponível.

1. Prescrição — O digital não encurta o cuidado

O que mudou

Desde 30 de setembro de 2026, sistemas de prescrição integrados ao Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR) podem emitir eletronicamente Notificações de Receita A, B e B2, notificações para retinoides de uso sistêmico e talidomida, além de Receitas de Controle Especial e Receitas Sujeitas à Retenção.

O profissional continua usando seu sistema de prescrição. Para as notificações numeradas, permanece necessária a numeração concedida pela Vigilância Sanitária local; a faixa eletrônica é distinta da física. A farmácia pode consultar a autenticidade, confirmar dados do prescritor e registrar a utilização. O SNCR controla o receituário; o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) continua responsável pela escrituração e pela movimentação dos medicamentos.

Por que importa

A integração cria rastreabilidade e reduz parte da fricção do papel, mas não transforma automaticamente um documento digital em prescrição segura. Uma revisão de escopo publicada em 2024, baseada em dez estudos de farmácias comunitárias, encontrou melhora de legibilidade e, ao mesmo tempo, erros novos ou persistentes: instruções incompletas, dados ausentes, quantidade, dose, forma farmacêutica e medicamento. É contexto científico — não notícia desta semana e não avaliação do SNCR brasileiro.

Consequência prática

Para quem prescreve: confirmar com o fornecedor se o sistema está integrado; conhecer os modelos eletrônicos; solicitar à Vigilância Sanitária local a numeração específica quando ela for exigida; e manter conferência clínica antes da assinatura.

Para farmácias e drogarias: preparar os perfis “SNCR” e “SNCR-Farmácia” no Cadastro Anvisa, conferir os dados e registrar a utilização da receita eletrônica conforme a orientação oficial.

Para pacientes: receita eletrônica não se tornou obrigatória. Receitas em papel continuam possíveis, conforme as regras de cada categoria.

Até onde a evidência permite concluir

Até 29 de outubro, podem coexistir receitas brancas eletrônicas integradas e não integradas ao SNCR; a partir de 30/10, se uma receita branca for eletrônica, deverá estar integrada. Esse período de transição é das receitas brancas — não das notificações A, B e B2. A integração comercial anunciada por fornecedores deve ser confirmada no sistema efetivamente usado; anúncio de empresa não substitui teste operacional nem orientação da Anvisa.

Fontes primárias e contexto: [Anvisa — início da nova etapa do SNCR, publicado em 21/09/2026](#); [efeitos a partir de 30/09/2026](#); [Anvisa — portal do SNCR, consulta em 02/10/2026](#); [RDC nº 1.000/2025 — texto consolidado](#); [Farghali e Borycki — revisão de escopo, Healthcare, 26/06/2024](#).

2. Atenção primária — Tecnologia só entra quando o trabalho muda

O que mudou

Em 30 de setembro, o Ministério da Saúde e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) disponibilizaram a estratégia formativa do Combo APS para profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde. O conjunto reúne 17 ou 18 equipamentos, conforme a configuração da unidade, para condições prevalentes nos territórios. A plataforma começou com cinco cursos autoinstrucionais de 10 horas sobre tecnologia biofotônica e prevê guias, procedimentos operacionais padrão e manuais para os demais equipamentos.

Por que importa

Dermatoscópio, Doppler vascular, eletrocardiógrafo, espirômetro e retinógrafo podem ampliar o que a Unidade Básica de Saúde reconhece e resolve. Mas disponibilidade física não é capacidade assistencial: interpretação, indicação, manutenção, registro, Telessaúde e referência precisam formar o mesmo processo.

Consequência prática

Equipes podem acessar gratuitamente os cursos e materiais já publicados. Gestores devem evitar a contagem simplista de “equipamento entregue”: a unidade de acompanhamento é equipamento disponível e profissional habilitado e fluxo assistencial definido.

Até onde a evidência permite concluir

A abertura da formação é verificável; impacto sobre acesso, diagnóstico, encaminhamentos ou desfechos ainda não foi demonstrado por essa comunicação. Parte dos materiais será disponibilizada progressivamente.

Fontes primárias: Ministério da Saúde — estratégia formativa, 30/09/2026, atualizada em 01/10/2026; UNA-SUS — página da Estratégia Formativa Combo de Equipamentos para UBS, consulta em 02/10/2026.

3. Hemoterapia — A norma mudou; a transição precisa ser explícita

O que mudou

Entrou em vigor em 30 de setembro de 2026 a Portaria GM/MS nº 11.685/2026, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017 e redefine regulamentos técnicos para sangue e procedimentos hemoterápicos no Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.

Por que importa

O marco técnico do Ministério da Saúde e as regras sanitárias da Anvisa funcionam de modo complementar. Durante a transição, a RDC nº 34/2014 continua disciplinando as Boas Práticas no Ciclo do Sangue, enquanto a Agência conduz sua atualização. Divergência interpretativa entre serviço e fiscalização pode produzir insegurança justamente onde uniformidade protege doadores e receptores.

Consequência prática

Serviços de hemoterapia e vigilâncias sanitárias locais devem trabalhar com a Portaria nova, a RDC ainda vigente e a Nota Técnica nº 42/2026 da Anvisa, documentando as providências de adequação e os pontos que dependem de harmonização regulatória.

Até onde a evidência permite concluir

A entrada em vigor é fato normativo. A comunicação oficial não demonstra, por si, melhoria de qualidade, segurança ou desfecho clínico; esses efeitos dependem da implementação e da fiscalização.

Fontes primárias: Portaria GM/MS nº 11.685/2026 — DOU, publicada em 03/07/2026; vigência em 30/09/2026; Anvisa — Nota Técnica nº 42/2026 e orientação de transição, 16/07/2026; Anvisa — síntese regulatória, 16/07/2026.

4. Terapias avançadas — O laboratório vem antes do acesso

O que mudou

Em 29 de setembro, Ministério da Saúde, Fiocruz, Secretaria da Saúde do Ceará, HU Brasil e Universidade Federal do Ceará assinaram memorando para criar, no Ceará, o segundo laboratório modular brasileiro dedicado ao desenvolvimento e à produção de células CAR-T — linfócitos T do próprio paciente modificados em laboratório para reconhecer alvos tumorais.

O plano integra uma estratégia de produção descentralizada. A primeira unidade modular foi instalada em maio em Bio-Manguinhos/Fiocruz, no Rio de Janeiro; a expansão prevê desenvolvimento tecnológico, produção de vetor lentiviral e estudos clínicos em parceria com o Instituto Nacional de Câncer.

Por que importa

Produzir mais perto dos centros assistenciais pode reduzir tempo e logística de uma terapia personalizada. Também cria capacidade nacional num campo de alto custo e dependência tecnológica.

Consequência prática

Para serviços e pacientes, ainda não há nova porta assistencial anunciada nesta semana. O marco útil agora é acompanhar implantação, autorização regulatória, protocolos de pesquisa, critérios de elegibilidade e eventual incorporação ao SUS.

Até onde a evidência permite concluir

Houve assinatura de memorando e anúncio de implantação. Isso não equivale a laboratório operacional, ensaio aberto, registro sanitário, incorporação ou tratamento disponível. A indicação inicial mencionada — leucemias e linfomas — permanece uma expectativa do programa.

Fonte primária institucional: [Ministério da Saúde — memorando para laboratório CAR-T no Ceará, publicado em 29/09/2026 e atualizado em 30/09/2026](#).

O que a VIA leva desta semana

- Digitalizar a receita melhora o traço documental; não substitui decisão clínica, conferência nem vínculo.
- Prazo regulatório tem sujeito: a transição até 29/10 é das receitas brancas eletrônicas, não das notificações A e B.
- Equipamento entregue é insumo. Capacidade assistencial exige gente treinada, fluxo, manutenção, registro e retaguarda.
- Norma em vigor não prova implementação uniforme.
- Laboratório anunciado não é terapia disponível.

O fio da semana é a distância entre habilitar e realizar. O SNCR habilita uma nova via; a formação habilita o uso de equipamentos; a Portaria reorganiza a regra; o memorando habilita infraestrutura. Em todos os casos, a pergunta seguinte é a mesma: o circuito consegue transformar possibilidade em cuidado seguro?

Método editorial

Recorte principal: fatos com efeito ou anúncio material entre 28/09 e 02/10/2026, preparados antecipadamente para a edição de 04/10. Fontes oficiais foram abertas no registro específico; literatura foi usada apenas para contextualizar a segurança da prescrição eletrônica. A revisão de 2024 não foi apresentada como fato novo. Comunicação comercial privada sobre integração de plataforma foi excluída como evidência; a edição orienta confirmação operacional com o fornecedor e a Anvisa.

Material educativo. Não substitui avaliação clínica individual, protocolo assistencial, norma sanitária nem fonte epidemiológica em tempo real. Não é bula, laudo, autorização de uso ou confirmação de integração de software. Conduta parte de prescrição, contexto e vínculo clínico.

Dr Lucas HR Almeida Editorial · Médico generalista (FMRP-USP) CRM-SP 226836 · CRM-MG 109752